

26 - Le Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) - Pr. AABBASSI

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule « Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité » ou ce qui est connu communément par abréviation TDAH. Au terme de ce cours, vous serez capables de définir le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, de connaître les différentes présentations cliniques, de poser le diagnostic positif, d'éliminer les diagnostics différentiels, d'orienter les prises en charge thérapeutiques et d'accompagner l'enfant et sa famille. Nous allons suivre le plan suivant.

Le TDAH est un trouble neurologique associant un déficit d'attention, une hyperactivité motrice et une impulsivité non adaptée au stade de développement. Ces difficultés ont un caractère stable, permanent et envahissant. Stable, c'est-à-dire qu'ils sont présents presque chaque jour.

Permanent, c'est-à-dire que ces difficultés remontent à au moins 6 mois et envahissant que c'est visible dans tous les domaines de vie de l'enfant en moins d'eux, comme à l'école, en famille et avec les amis. Sa première description remonte à 1920. C'est un trouble fréquent, largement médiatisé, mais retenez que c'est un diagnostic d'élimination, qu'il faut éliminer d'autres causes plus importantes du déficit de l'attention et de l'hyperactivité motrice avant de retenir le TDAH.

Son diagnostic reste purement clinique. Son traitement est codifié par des consensus internationaux et le pronostic, c'est un trouble chronique qui peut affecter la qualité de vie de l'enfant et de sa famille. Qu'en est-il de l'épidémiologie ? C'est un trouble fréquent qui touche quand même 6% des enfants, soit un enfant par classe en France avec une prédominance masculine de 3 garçons pour 1 fille.

L'âge de diagnostic est environ 9 à 10 ans. Il est hautement comorbide. Dans les deux tiers des cas, il est associé à un autre trouble neurologique ou psychiatrique que nous allons voir en détail après et que 50 à 60% de ces enfants y vont conserver le trouble à l'âge adulte.

Pour l'éthiopathogénie, Steele qui a décrit en 1920 le premier cas de TDAH et qui est un neuropédiatre américain avait posé comme cause du TDAH la cause neurologique parlant de minimal brain dysfunction ou un dysfonctionnement cérébral minime. Les pédopsychiatres européens, eux, parlent d'origine affective éducative environnementale, c'est-à-dire soit une carence des émotions, des affections et des soins de l'enfant, soit par un manque éducationnel et un manque des limites posées par les parents ou parce qu'il y a une cause environnementale de stress que les enfants vont développer le TDAH. Mais actuellement, nous parlons de trouble neurodéveloppemental précoce et multifactoriel c'est-à-dire que c'est un trouble qui est dû à un déficit développemental très précoce au niveau cérébral, même en intra-utérin et que c'est dû à plusieurs facteurs que nous allons détailler par la suite.

Donc voilà, récemment nous avons dit que nous retenons le TDAH comme étant un trouble

neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un dysfonctionnement dans le lobe frontal des cerveaux avec une prédisposition génétique. Le lobe frontal et ce qui est marqué sur l'image en bleu, c'est la zone du cerveau qui est responsable de la tension aussi bien visuelle qu'auditive de l'inhibition de l'impulsivité c'est-à-dire que le contrôle des gestes, de la mémoire du travail de la méthodologie du travail et de la prise d'initiative lors d'une tâche. Le TDAH serait lié à un dysfonctionnement des neurotransmetteurs, notamment la dopamine en cette zone du cerveau qui sera donc responsable d'un manque de contrôle de certains comportements.

La cause génétique est relatée dans 80%. Lorsqu'il y a un antécédent familial de TDAH, il y a un risque d'avoir ce trouble x5. Il y a certaines causes environnementales qui peuvent favoriser et prédisposer au TDAH.

C'est la prématurité, le retard de croissance intra-utérin, le faible poids de naissance, l'exposition au cours de la grossesse au tabac, la caféine, les antidépresseurs et les anticonvulsivants, la dépression et l'anxiété chez la maman et les relations précoces mère-bébé qui sont défaillantes par manque de stimulation et carence de soins. Les causes neurologiques, il y a une anomalie de la structure du cerveau notamment du lobe préfrontal et du cervelet. Également, il y a les anomalies de la chimie du cerveau avec une diminution du débit sanguin et un déficit en dopamine comme on a dit tout à l'heure.

Il s'agit ici d'un syndrome désexécutif, c'est-à-dire un déficit de toutes les fonctions cérébrales qui permettent d'élaborer correctement une tâche. En TDAH, il y a un déficit d'attention, de mémoire, des difficultés d'inhibition de l'action ou de l'activation lors d'une tâche. Donc voilà, si on veut résumer, nous allons retenir ce qu'a dit Thomas Brown en 2005 qui est un neuropédiatre anglais qui a dit que le TDAH n'est pas un déficit d'attention mais bien un déficit en les capacités de moduler, de freiner et d'inhiber une tâche.

Pour l'étude clinique, 3 symptômes cardinaux c'est le déficit de l'attention qui est le symptôme le plus important de la triade. Il y a l'hyperactivité motrice et il y a l'impulsivité. La forme la plus fréquente étant la forme mixte qui associe le trouble de l'attention avec l'hyperactivité motrice.

Généralement, c'est un écolier garçon entre 6 et 12 ans qui est adressé pour des difficultés scolaires, pour une turbulence en classe et ça génère généralement un épuisement familial. Il se présente pour la triade symptomatique, déficit d'attention, hyperactivité motrice et impulsivité qui ont un caractère stable, presque quotidien, permanent, évoluant depuis au moins 6 mois et envahissant et invalidant sur le plan scolaire, familial et relationnel. Le déficit de l'attention, c'est un enfant rêveur qui semble ne pas écouter, il est distrait, il évite les tâches difficiles, il est parasité par les stimulations, il a des oublis qui sont fréquents avec de grandes difficultés d'apprentissage.

L'hyperactivité motrice, c'est un enfant qui est toujours en mouvement, il est agité avec une activité désorganisée, il est incapable de rester en place, ne sait pas jouer en silence, il est

difficile à calmer. C'est généralement le symptôme le plus dérangeant pour l'entourage. L'impulsivité, l'enfant est impatient, il est maladroit, il prend des risques, il coupe la parole, il répond avant la fin des questions, il travaille sans stratégie, il change souvent d'activité et comme on a dit, il peut prendre des risques.

Il a aussi des sauts d'humeur et des crises de colère qui sont très fréquentes. Les comorbidités sont très fréquentes et il faut toujours les chercher. 87% des enfants TDAH ont au moins un diagnostic comorbide.

Il s'agit de dépression, d'anxiété, de troubles oppositionnels avec provocation, ce sont des enfants qui sont opposants tout le temps qui vont s'opposer à toute figure d'autorité qui soit parent ou éducateur. Les troubles du spectre autistique, les troubles spécifiques des apprentissages comme la dyslexie, comme la dysorthographe, comme la dyscalculie et les dyspraxies, les épilepsies sont fréquemment associées au TDAH, l'éthique et le syndrome de Gilles de La Tourette. A côté de cette forme très fréquente, on a d'autres formes cliniques.

Selon les 5 cliniques dominants, on parle de forme inattentionnelle prédominante lorsqu'il y a de l'inattention et de l'hyperactivité, mais que l'inattention est la plus prédominante sur le tableau clinique. La forme inattentionnelle restrictive, c'est-à-dire qu'il y a surtout de l'inattention, l'hyperactivité est quasiment absente. C'est une forme qui se voit surtout chez les filles.

Et la forme hyperactive ou impulsive où il y a surtout de l'hyperactivité et de l'impulsivité avec ou sans un léger déficit d'attention. Selon l'âge. Chez l'enfant tout petit, on a plutôt l'instabilité motrice qui prend le devant.

Chez le préadolescent, c'est les comportements impulsifs qui vont attirer notre attention. Chez l'adolescent, c'est surtout les déficits de l'attention donnant des difficultés scolaires. L'étude de diagnostic.

Comment porter le diagnostic positif de TDAH? Nous avons dit que c'est un diagnostic d'élimination qui vient à la fin de la liste d'autres diagnostics qu'on va rechercher qui peuvent être en cause de la triade symptomatique. C'est un diagnostic purement clinique. Votre évaluation clinique est suffisante pour le porter.

Cette étude de diagnostic doit être précoce pour poser le diagnostic positif précocement avant l'installation de séquelles au niveau scolaire et au niveau relationnel et affectif chez l'enfant. Et cette démarche diagnostique se fait auprès de l'enfant, de la famille et de l'école. Nous commençons par l'anamnèse.

Nous cherchons la triade symptomatique et nous évaluons depuis quand il y a ces trois symptômes où se manifestent ces symptômes est-ce que plus à l'école ou en famille ou avec les amis par exemple et depuis combien de temps cela évolue pour chercher le caractère stable, envahissant et permanent que nous avons détaillé tout à l'heure. Nous allons détailler l'histoire de

développement pour chercher les facteurs environnementaux de risque les antécédents médicaux, psychiatriques, personnels et familiaux nous allons explorer le fonctionnement global de l'enfant comment il se comporte, comment est son tempérament dans les différents domaines de vie et la réaction de la famille, de l'école et de l'entourage à ces symptômes. L'observation de l'enfant peut se faire en consultation et le mieux s'il est possible de le faire à l'école.

Gardez à l'esprit et soyez attentif que l'enfant peut rester calme en situation nouvelle votre première rencontre avec l'enfant peut être trompeuse, il peut se maîtriser il peut se contrôler et vous n'allez pas relever le symptôme d'hyperactivité qui fait partie du tableau clinique vous allez recueillir les données par les courriers que vous allez adresser à l'école que l'école va vous adresser, par les carnets scolaires et les observations qui sont notées dessus et par un type de questionnaire qu'on appelle les questionnaires de CONERS version parents et version enseignants où il y a un ensemble de questions que vous allez poser aux parents et à l'enseignant pour relater le comportement de l'enfant. L'examen somatique va rechercher par exemple des cicatrices de chute ou des traces de maltraitance Exemple de cicatrices qui est très caractéristique des enfants TDH ou plutôt fréquente chez ces enfants c'est les blessures de l'arc de sourcil par des chutes frontales sur le front. Par votre anamnèse et votre observation de l'enfant vous allez établir ce qu'on appelle un pré-diagnostic positif en tant que médecin première ligne, votre tâche de diagnostic s'arrête là et donc vous aurez besoin de confirmation de diagnostic donc vous allez l'adresser à des équipes spécialisées pour des évaluations spécialisées.

Il peut s'agir d'équipes pédopsychiatriques ou d'équipes de neuropédiatrie. En milieu spécialisé nous utilisons quelques échelles diagnostiques comme le ADHD rating scale ou l'échelle de TDH. Le WISC pour le caution intellectuelle le barrage de cloche et le trouble test sont des tests attentionnels.

Le bilan orthophonique est nécessaire pour rechercher les comorbidités avec les troubles spécifiques des apprentissages et le bilan psychomoteur permet de donner une idée sur le développement psychomoteur de l'enfant. La classification internationale des maladies mentales d'ASM5 définit le TDH comme faisant partie des troubles neurodéveloppementaux par rapport à l'ancienne version le début doit être avant 12 ans et qu'elle dure plus de 6 mois qu'il doit être présent dans au moins 2 domaines de vie aussi bien en famille qu'à l'école qu'il doit avoir un retentissement entre avant le développement normal et adaptatif et la nouveauté de l'ASM5 c'est que n'exclut pas le diagnostic de TDH, il y a un trouble du spectre autistique associé ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de l'ASM5. Voici la triade symptomatique si vous voulez voir en détail quels sont les signes qu'on va rechercher pour retenir le diagnostic tout ça on l'a vu ensemble dans l'étude clinique Donc maintenant le diagnostic positif mais avant il y a le diagnostic différentiel j'insiste toujours que le TDH est un diagnostic d'élimination il y a d'autres causes qui peuvent être à l'origine de la triade comme les causes organiques telles que les épilepsies les déficits sensoriels, le retard mental la dysthyroïdie et les maladies génétiques comme le

syndrome de l'ex fragile il y a les causes psychiatriques comme le TSA, comme les dépressions l'anxiété, la carence affective et la maltraitance comme les prises médicamenteuses et les difficultés éducationnelles c'est-à-dire que les parents n'arrivent pas à instaurer les limites éducationnelles avec l'enfant le diagnostic différentiel se porte par une anamnèse rigoureuse pour un examen clinique minutieux qu'elle soit dysmorphique ORL, ophtalmologique, neurologique, thyroïdien et s'il y a nécessité de bilan paraclinique comme le EG, les potentiels évoqués auditifs et le bilan thyroïdien Comment on traite ces enfants? D'abord il y a la psychoéducation c'est-à-dire l'éducation sur le trouble on va informer l'enfant et informer les parents sur ce trouble on va le définir on va parler de ses origines on va expliquer les signes cliniques qui sont dans le tableau clinique et on va également expliquer quelle sera la prise en charge ultérieurement la psychoéducation comporte aussi des conseils aux parents qu'il faut être clair avec ses enfants et ferme il faut être bienveillant aussi il faut adapter une routine avec des temps de pause, ce qu'on appelle le temps on-off le temps off est le temps de repos et le temps on c'est le temps de travail, par exemple il peut travailler 15 minutes, c'est le temps on il peut se reposer 10 minutes, c'est le temps off il faut responsabiliser l'enfant l'hygiène de vie, une routine de sommeil correct avec une activité physique régulière améliore les signes cliniques une nutrition équilibrée sans excitants avec parfois la supplémentation en fer peut aussi être bénéfique pour ses enfants.

La rééducation orthophonique et psychomotrice est indiquée aussi les aménagements scolaires, comme on a dit le temps on-off qui peut également se faire à l'école, c'est à dire que l'enfant lorsqu'il va s'épuiser on peut lui autoriser une petite pause puis il reprend son activité on va adapter les examens puisqu'il a des difficultés d'attention et de concentration, cela peut générer une lenteur et donc possible qu'il aura besoin de plus de temps pour faire ses évaluations le soutien scolaire aussi est indiqué la psychothérapie d'ordre comportemental agissant sur les comportements cognitifs, agissant sur les idées sur l'attention et sur les capacités mentales, qu'elle soit d'approche émotionnelle lorsqu'il y a surtout une baisse de l'estime de soi elles peuvent trouver aussi leur place chez ses enfants Pour les médicaments, la molécule la plus célèbre pour le traitement de TDAH à travers le monde est la méthylphenidate, commercialisée sous le nom de Rétaline en France ou Rélatine en Belgique la Rétaline LP ou la Rélatine LP sont les formes de dispersion prolongée ou le Concerta en Espagne et le Concerta LP il s'agit d'un psychostimulant il ne va pas stimuler la motricité mais il va stimuler les capacités mentales d'attention et de concentration permet de diminuer le signe clinique et aide à la planification et est réputée efficace et bien tolérée malheureusement on n'est pas encore commercialisé au Maroc mais procurable par une ordonnance marocaine avec un rapport qu'on va adresser soit à des spécialistes en France ou en Espagne pour avoir la dotation en médicaments se donne à partir de 6 ans à la dose de 0,5 à 1 mg kg par jour, jamais avant 6 ans que dans certains cas particuliers avec maximum 60 mg par jour et qui sera donné en deux prises la première prescription se fait en milieu hospitalier avec un suivi rapproché notamment sur le plan respiratoire et surtout cardiovasculaire sa prescription se fait normalement sur 2 ans avec une réévaluation clinique et il y a possibilité de fenêtres thérapeutiques c'est à dire d'arrêter le

traitement chez l'enfant les week-ends et les vacances scolaires il y a d'autres molécules aussi comme l'atome oxytène qui agit surtout sur les versions de déficit d'attention il y a les antidépresseurs comme l'ancienne génération des antidépresseurs qu'on appelle les antidépresseurs tricycliques montrent dans certaines études leur efficacité sur les symptômes de TDRH mais ils ont beaucoup d'effets secondaires et il y a la clonidine donc en première intention toujours on fait un traitement multimodal et multidisciplinaire basé sur la psychoéducation surtout sur la rééducation et sur les aménagements scolaires et s'il y a lieu de faire une psychothérapie en cas d'efficacité limitée ou d'inefficacité en deuxième intention on associe la prescription médicamenteuse avec un suivi médical rapproché le poids, la taille et la tolérance la taille et le poids parce que la méthylphénidate peut donner un retard de croissance pour l'évolution et le pronostic il s'agit d'un trouble chronique continu à l'âge adulte dans plus que la moitié des cas c'est à dire lorsque vous allez diagnostiquer chez un enfant ou un adolescent un TDRH il va le conserver jusqu'à l'âge adulte le traitement adéquat permet une bonne qualité de vie et la réussite scolaire mais dans certains cas le trouble reste invalidant et handicapant causant du rejet social et de l'instabilité relationnelle de l'épuisement familial et par conséquent de la maltraitance une baisse de l'estime de soi, de la dépression et de l'anxiété, des difficultés scolaires qui peuvent aller jusqu'à l'échec scolaire et le décrochage scolaire En conclusion, l'enfant avec TDRH n'est pas simplement un enfant trop actif et turbulent. Le TDRH est une situation de souffrance c'est un trouble qui interfère avec les capacités mentales de l'enfant et peut devenir invalidant sur le plan familial, social et scolaire d'où tout l'intérêt de le diagnostiquer correctement et de le prendre en charge de façon adéquate et précoce